

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – НАВСТРЕЧУ ТРЕТЬЕМУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ

*Тезисы докладов
научно-практической конференции*

ПЕРМЬ 2000

УДК 61(063)

ББК 5

М 755

ISBN 5-7812-0080-0

В сборнике представлены тезисы докладов молодых ученых ПГМА: аспирантов, ассистентов, клинических ординаторов и др.; работа выполнена под руководством опытных наставников – профессоров и доцентов.

Доклады посвящены актуальным проблемам современной медицины, отражают перспективные направления медицинской науки.

Редакционная коллегия:

М.А.Данилова,

С.А.Степанов,

Н.Н.Углева,

А.А.Шурыгин,

А.А.Шутов

ISBN 5-7812-0080-0

© Пермская государственная
медицинская академия, 2000

Н.В.Светлакова

РЕАКТИВНОСТЬ БРОНХОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Кафедра госпитальной терапии №2

Снижение иммунореактивности, функциональных возможностей организма у больных сахарным диабетом (СД) выявлено многими исследователями. В частности это относится к поражению бронхолегочного аппарата. Отмечено, что уже в первые годы болезни изменяется функция внешнего дыхания при отсутствии проявлений бронхолегочной и сердечно-сосудистой патологии. Морфологическим субстратом, обуславливающим частое присоединение заболеваний легких, а также смену характера течения предсуществующей легочной патологии при развитии СД, по-видимому, является диабетическая микроангиопатия, полинейропатия. Известно, что при присоединении СД течение бронхиальной астмы претерпевает значительные изменения. Можно пред-

положить, что у больных СД возникают изменения реактивности бронхов.

Цель нашего исследования – попытка охарактеризовать реактивность бронхиального дерева у больных сахарным диабетом.

Нами обследовано 40 больных СД I типа, в возрасте от 15 до 59 лет, средний возраст составил $(33 \pm 1,6)$ года, 52,5% группы – мужчины. У большинства больных (60%) СД имел течение средней тяжести, а углеводный обмен был декомпенсирован в 70% случаев. Средний стаж длительности СД составил $(11 \pm 1,1)$ лет. Сосудистые осложнения диабета наблюдались у 95% пациентов. Выделено 2 группы больных: 1-я – 31 пациент с СД без исходной патологии органов дыхания, 2-я – 9 больных СД с исходно скомпрометированным бронхолегочным аппаратом (длительное курение, наличие хронического бронхита).

Нами изучались клинические проявления болезни, особенности анализов крови и мочи, а с помощью пикфлоуметрии оценивали проходимость бронхов измерением пиковой, объёмной скорости выдоха (ПОСВ) утром и вечером в течение 6 дней. Фиксировали «утренние провалы» (ситуация, когда различие между утренним и вечерним показателями ПОСВ более 20% при условии, что утренний показатель ниже вечернего), индекс суточной вариабельности (ИСВ) пиковой скорости выдоха. Полученные изменения сравнивали с таковыми контрольной группы, состоящей из 20 здоровых женщин (средний возраст $(25,0 \pm 0,3)$ года).

Установлено, что ИСВ, отражающий вариабельность реактивности бронхов, составляет $(17,6 \pm 1,3)\%$ в первой группе, $(30,6 \pm 5,1)\%$ – во второй, что достоверно выше, чем в контрольной группе – $(10,4 \pm 1,1)\%$. Это свидетельствует о патологической реактивности бронхов у больных СД, особенно, если СД протекает на фоне исходной патологии бронхов с клиническими проявлениями обструктивного синдрома (различие по ИСВ между 1-й и 2-й группами достоверно). Наличие «утренних провалов» зафиксировано у 9% пациентов 1-й группы и у 44% – 2-й. В контрольной группе ПОСВ всегда была выше 80% от нормы, «утренние провалы» отсутствовали. При оценке общего анализа крови выявлена анэозинофилия у 21% больных 1-й группы и у 33% – 2-й группы.

Причины и механизмы субклинических проявлений обструкции бронхов нуждаются в дальнейшем изучении. Исследования, проведенные В.В.Вытрищакон (1993), позволили установить инсулинзависимый механизм обструкции бронхиального дерева.

Таким образом, поражение бронхолегочного аппарата при СД проявляется в виде гиперреактивности, без клинических проявлений обструктивного синдрома. Если СД протекает на фоне исходно пораженных бронхов, то уровень их реактивности достоверно выше, и за-

частую проявляется клиникой обструкции. Анэозинофилия, выявляемая у части больных 1-й и 2-й групп, отражает изменение иммунореактивности организма.

Метод пикфлоуметрии можно рекомендовать для диагностики изменений реактивности бронхиального дерева и оценки адекватности лечения.